随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、胰岛素瘤

1.**Whipple 三联征**：①空腹或运动后出现低血糖症状（头晕、出汗、心慌等）；②发作血糖常＜2.8；③补葡萄糖迅速缓解

兴奋交感N

注意：若无低血糖症状发作→72 小时饥饿试验（饿吧）

低血糖标准:正常人<2.8,糖尿病患者<3.9
Somogyi效应:夜间低血糖(<3.9)后反跳性高血糖,应减少夜间给胰岛素

餐前低血糖：胰岛素瘤

餐后低血糖：晚期倾倒综合征（进食后 2-4 小时发生）、某些早期 2 型糖尿病

胰岛素来的晚　胰岛素分泌高峰延迟

2.90%单发、良性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→首选手术

看生物学行为:甲状腺滤泡癌、胰腺内分泌肿瘤

三、胃泌素瘤

胰腺里面没有G细胞,但原始干细胞错误的分化成了一种能够分泌胃泌素的细胞

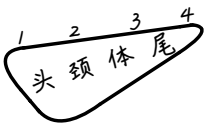
1.好发**胃泌素瘤三角**

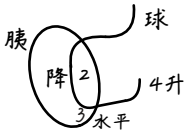
胆总管起始部✓

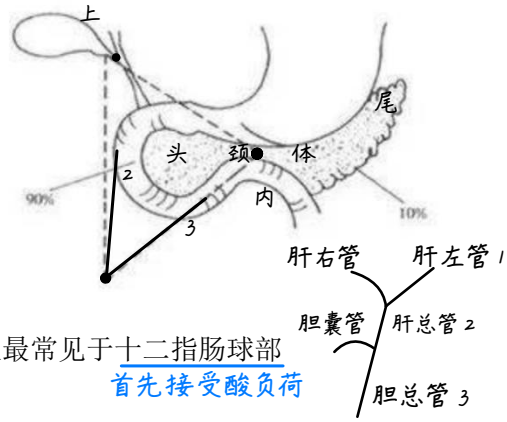
①上起胆囊管和**胆总**管交界处（干扰：肝总管起始部）

②下至十二指肠**降部及水平部**交点 23

③内至胰**颈体**交界处 23







2.**Zollinger-Ellison 综合征**（easy）

十二指肠以后:正常偏碱性

①顽固性消化性溃疡：十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段等，但最常见于十二指肠球部

首先接受酸负荷

②腹泻 胃泌素"全兴奋":消化液分泌+消化道运动↑



3.诊断

basic

基础胃酸分泌量　最大胃酸分泌量

①无胃手术史者基础胃酸排出量 BAO＞15、胃大部切除术后者 BAO＞5、BAO/MAO＞0.6

Max

②胃液 pH≤2 且胃泌素超过正常上限 10 倍 ttsx 胃泌素瘤五五开,给你耳屎胃酸嗨

0.6 5 15　2 10

病变的根源在胰腺

4.60-70%恶性（区分良恶性主要依据侵犯和转移）→**Whipple 术切除肿瘤+PPI 控制高胃酸**

胰头十二指肠切除 Whipple 术适合：胰头癌、壶腹癌、下段胆管癌、十二指肠癌、胃泌素瘤（下蛋 1 年喂一壶）

1年

真题解析·胰腺肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N147-148 B

A.Zollinger-Ellison 综合征 胃泌素瘤60~70%恶性

B.Budd-Chiari 综合征

C.Peutz-Jeghers 综合征 黑斑息肉综合征

D.Gardner 综合征 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤　大肠癌癌前病变

最容易发生消化性溃疡的是

完全与恶性肿瘤无关的是

抑制α亚基的GTP酶活性,导致α亚基结合的GTP不能被水解为GDP,因此α亚基处于持续活化状态

腹泻
- 分泌性：胃泌素瘤、霍乱
- 吸收不良性:小肠切除术后、慢性胰腺炎
- 渗出性:炎症
- 渗透性:乳糖酶缺乏
- 动力性:肠炎、甲亢、糖尿病

胃泌素瘤五个类型都有,只是主要为分泌性

2.2015N84 A 胰头癌常见的首发表现是　癌中之王

A.脂肪泻

B.黄疸

C.贫血